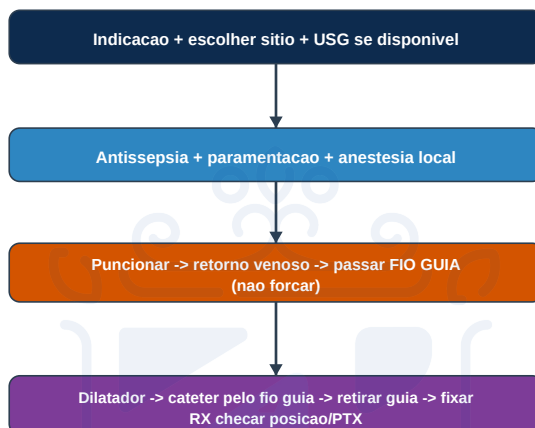


ACESSO VENOSO CENTRAL — TÉCNICA E SÍTIOS

FLUXOGRAMA — TÉCNICA DE SELDINGER

ACESSO CENTRAL — PASSO A PASSO



INDICAÇÕES

QUANDO ESTÁ INDICADO

- Impossibilidade de acesso venoso periférico
- Medicamentos com alto risco de flebite: NPT, vasopressores, quimioterapia, soluções hiperosmolares
- Paciente grave em uso de múltiplas medicações (cateter com 2-3 vias)
- Necessidade de monitorização (PVC) ou terapias específicas (hemodiálise — cateter próprio)

CONTRAINDICAÇÕES E CUIDADOS

ATENÇÃO ANTES DE PUNCIONAR

- Distúrbios de coagulação / plaquetopenia < 20.000 (relativa) — preferir femoral (compressível)
- Trombose do vaso a ser puncionado
- Infecção / lesão no sítio de punção
- Sempre usar USG para guiar a punção quando disponível (reduz complicações)
- Não introduzir a agulha além do necessário em jugular/subclávia (risco de pneumotórax)

MATERIAIS

PREPARO DA MESA

- Gaze, clorexidina alcoólica, luva e campo estéril
- Seringa 20mL, agulha rosa (40x12) e agulha fina (30x7) para botão anestésico
- Lidocaína 2% (anestésico local), soro fisiológico, cuba rim
- Kit do cateter central (agulha, fio guia, dilatador, cateter)
- Kit cirúrgico básico (porta-agulha, tesoura) + fio mononylon 3-0 ou 2-0 para fixação

SÍTIOS — VANTAGENS E DESVANTAGENS

Sítio	Marco / relação anatômica	Prós e contras
Jugular interna	Triângulo de Sedillot; veia LATERAL à carótida; ~2-3 cm de profundidade	Compressível, pouca infecção; risco de PTX e hematoma cervical. Preferir à DIREITA (trajeto reto)
Subclávia	0,5 cm lateral/inferior ao tubérculo conoide; agulha rente à pele, rumo à fúrcula	Menos infecção, menos variação; NÃO compressível; MAIOR risco de PTX
Femoral	Veia MEDIAL à artéria femoral; punção medial ao pulso, 45 graus	Compressível, SEM risco de PTX; MAIS infecta. Preferência se discrasia

TÉCNICA — PONTOS-CHAVE POR SÍTIO

Rx EXECUÇÃO

Posição: DDH, Trendelenburg (jugular/subclávia — veia mais túrgida), face para o lado oposto
JUGULAR: punção no ápice do triângulo, agulha 45 graus rumo ao mamilo ipsilateral, LATERAL ao pulso carotídeo
Se punccionar artéria (sangue vivo/pulsátil): retirar e COMPRIMIR; punccionar lateral à tentativa prévia
SUBCLÁVIA: bater na clavícula e passar ABAIXO do osso, agulha quase paralela à pele, rumo à fúrcula
FEMORAL: punção medial ao pulso femoral, 45 graus; rotação externa leve do membro
Seldinger: retorno venoso -> fio guia (sem forçar) -> dilatador -> cateter -> retirar guia -> fixar com sutura

COMPLICAÇÕES — RED FLAGS

RECONHECER E AGIR

- Pneumotórax (jugular/subclávia): dispneia, dessaturação, MV abolido -> RX/USG, drenar se hipertensivo
- Punção arterial: comprimir; se dilatou a artéria, vigiar hematoma expansivo (cervical pode ser grave)
- Embolia gasosa: manter Trendelenburg e ocluir o canhão ao manipular
- Arritmia: fio guia profundo demais — tracionar
- Sempre confirmar posição da ponta e excluir PTX com RX de tórax antes de usar a via (exceto urgência)

CHECKLIST FINAL

ANTES DE LIBERAR O CATETER

- ☐ Retorno venoso em todas as vias + lavar com SF
- ☐ Cateter fixado com fio de sutura e curativo estéril
- ☐ RX de tórax: ponta em VCS (junção cavoatrial) e ausência de pneumotórax
- ☐ Registrar sítio, número de tentativas e intercorrências
- ☐ Reavaliar indicação diariamente e retirar assim que possível (prevenir infecção de corrente sanguínea)

DICA DE SEGURANÇA

ESCOLHA DO SÍTIO NA PRÁTICA

- Discrasia / plaquetopenia -> femoral (compressível, sem PTX)
- Necessidade de menor risco infeccioso e longa permanência -> subclávia (se coagulação ok e operador experiente)
- Emergência com USG -> jugular interna direita guiada é a mais versátil
- Na dúvida ou sem USG, escolha o sítio que você domina e tem material de resgate



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com plaquetopenia grave (< 20.000) e necessidade de acesso central. Qual o sítio preferencial e por quê?

- A) Subclávia, por ser o que menos infecta
- B) Jugular interna esquerda, por trajeto mais reto
- C) Femoral, por ser compressível e não causar pneumotórax
- D) Qualquer sítio, pois a coagulação não influencia
- E) Subclávia, por não ser compressível

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Durante punção de jugular interna, retorna sangue vermelho vivo e pulsátil ao retirar a seringa. Conduta?

- A) Progredir o fio guia rapidamente
- B) Retirar a agulha e comprimir o local; vigiar hematoma antes de nova tentativa
- C) Dilatar o trajeto imediatamente
- D) Trocar para o lado contralateral sem comprimir
- E) Introduzir o cateter assim mesmo

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual sítio de acesso venoso central apresenta o MAIOR risco de pneumotórax?

- A) Femoral
- B) Subclávia
- C) Jugular externa
- D) Basílica
- E) Nenhum causa pneumotórax

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Ao passar o fio guia pela técnica de Seldinger, há resistência logo no início. Qual a conduta mais segura?

- A) Forçar o fio guia até vencer a resistência
- B) Não forçar; reposicionar a agulha (tracionar/avançar) e reconfirmar retorno venoso com a seringa
- C) Dilatar o trajeto para facilitar a passagem
- D) Introduzir o cateter sem o fio guia
- E) Aumentar o calibre do dilatador

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre a relação anatômica nos sítios de punção, assinale a correta:

- A) Na jugular, a veia é medial à carótida
- B) Na femoral, a veia é lateral à artéria femoral
- C) Na jugular a veia é lateral à carótida; na femoral a veia é medial à artéria
- D) Em ambos os sítios a veia é sempre lateral à artéria
- E) A relação anatômica é irrelevante quando se usa USG

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Na discrasia/plaquetopenia grave, prefere-se o sítio femoral: é compressível (permite hemostasia por compressão) e não causa pneumotórax. Subclávia é não compressível — pior escolha nesse cenário.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Sangue vivo e pulsátil = punção arterial (carótida). Retirar a agulha e comprimir; em geral, se só punccionou sem dilatar, não forma hematoma. Localizada a artéria, puncionar lateral à tentativa anterior. Nunca dilatar/cateterizar a artéria.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A subclávia tem o maior risco de pneumotórax pela proximidade do ápice pulmonar; por isso a agulha deve correr rente à pele/abaixo da clavícula. A femoral não causa pneumotórax.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Resistência ao fio guia sugere agulha mal posicionada — NUNCA forçar (risco de lesão vascular). Reposicionar a agulha e reconfirmar o retorno venoso com a seringa antes de prosseguir.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Relação anatômica inverte-se: no pescoço a jugular interna é LATERAL à carótida; na virilha a veia femoral é MEDIAL à artéria femoral. Conhecer isso orienta a punção mesmo com USG.

SM24
Suporte ao Plantão Médico